SOMPOケア
介護の未来を変えていく

未来の介護

～1勝の定義　スコア詳細資料～
2504更新版

ＳＯＭＰＯケア株式会社
未来の介護推進部

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

未来の介護実践のストーリー　～変えていく・価値ある・感動できる～

フェーズ１
「1勝」

- ●実態把握
- ●カスタムメイドケア基礎

適切なケアプラン

QOL取り組み時間確保

フェーズ２
「品質向上」へ

過不足のないPDCAサイクル

非定時ケア問題の軽減

フェーズ３
「カスタムメイドケア実践」へ

自立支援実践

1人1人の生活の実現

参加の実現

ACPの実施

参考指標：「１勝」の10の評価項目達成後、「カスタムメイドケア実践」を図る10の評価項目達成へ！

資料格納先　ファイル管理＞egaku事業本部＞egakuプロダクト開発課

未来の介護（虎の巻上巻）

未来の介護（虎の巻下巻）

変えていく

価値ある

感動できる

三方良しの未来社会の実現へ

1勝の定義　～変えていく～　※フェーズ１ 完了基準

＜利用者 良し ＝尊厳のある生活＞

	目指す姿	判定項目
①	■ブランドサービスの価値が提供され、より豊かな生活が送れている	QOL取組み時間　月150分/人　以上
②	■状態に応じた適切なサービスを受けることができている	未実施率　5%未満
③	■ケアプランの内容にご本人の意思や意向が反映され、担当者会議で説明を受けている	ご本人のサービス担当者会議参加率90%以上

＜スタッフ 良し ＝働きがい・働きやすい職場の実現＞

	目指す姿	判定項目
④	■無理なく業務遂行できる業務スケジュールが組まれている	業務空き時間平均20%以上
⑤	■適切な提供時間、タイミングでサービス提供となるスケジュールが組まれている	援助別ミニマム時間設定60%以上
⑥	■ご利用者さまのQOL維持向上のために多職種で暮らしを支えられている	カスタムカンファ議事録作成率80%以上

＜事業者 良し ＝未来の介護モデルの創造＞

	目指す姿	判定項目
⑦	■QOL取組みの実施に向け、直接介護のケアライン数が既定本数に準じて運営できている	直接介護実施の業務ライン数　基準内
⑧	■将来、介護ができる人材が減ったとしても高齢者の生活を支え続けれる体制ができている	Qラインに直接介護0%
⑨	■過剰・過少援助とならぬよう、ご本人の状態にあったサービスが提供できている	過剰援助10%未満、過小援助60%未満

＜未来社会 良し ＝未来の介護モデルの創造＞

	目指す姿	判定項目
⑩	■介護品質の低下・業務負担の増加を適切に把握できる体制ができている	未タップ率2%未満、入院/退去後の未修正2名以下、排泄ズレ率20%未満

1勝の定義　～変えていく～　※ファーストstep 完了基準

No.	目指す姿	判定項目	点数（スコア）
①	ブランドサービスの価値が提供され、より豊かな生活が送れている	1名あたりのQOL取組み時間/月（Qタイム＋個別援助）	●Qタイム業務＋個別参加援助時間/月末入居者数で決める（1ヶ月間の時間を集計） 1人当たり150分以上で3点、90分以上で2点、30分以上で1点、30分未満で0点
②	状態に応じた適切なサービスを受けることができている	キャンセル率、未実施率	●5%未満：3点、10%未満：2点、15%未満：1点、15%以上：0点
③	ケアプランの内容にご本人の意思や意向が反映され、担当者会議で説明を受けている	ご本人のサービス担当者会議参加率90%以上	●90%以上達成3点、80%以上達成2点、70%以上達成1点、70%未満0点
④	無理なく業務遂行できる業務スケジュールが組まれている	業務ゆとり時間（空き時間）割合	●直接介護における業務ゆとり時間平均が 20%以上で3点、15%以上20%未満で2点、、5%以上15%未満で1点、5%未満0点 ※夜勤以外の直接介護ラインのみ※上限は不問とする
⑤	適切な提供時間、タイミングでサービス提供となるスケジュールが組まれている	援助別ミニマム時間	【6項目の援助について（オムツ交換・トイレ介助・着脱介助・口腔ケア介助・食事介助・入浴介助）】 ●ミニマム時間6割以上：2点、ミニマム時間を2割～6割未満：1点
⑥	ご利用者さまのQOL維持向上のために多職種で暮らしを支えられている	カスタムカンファ議事録作成率80%以上	●80%以上：3点、70%以上：2点、60%以上：1点、60%未満：0点
⑦	QOL取組みの実施に向け、直接介護のケアライン数が既定本数に準じて運営できている	直接介護実施の業務ライン数	●直接援助のケアライン数の基準内：3点 ●直接援助のケアライン数より多いが1本未満：2点 ●直接援助のケアライン数より1本多い：1点 ●上記以外　0点
⑧	将来、介護ができる人材が減ったとしても高齢者の生活を支え続けれる体制ができている	Qラインに直接介護が入っていない	●Qラインに直接介護が0%であれば3点、5%未満で2点、10%未満で1点、10%を超えると0点 ※QラインはAxist上「動かさない」を基本ルールとする。Qラインが存在しない場合は3点とする
⑨	過剰・過少援助とならぬよう、ご本人の状態にあったサービスが提供できている	援助量と介護度の一致	●過剰10%未満＋過少60%未満で3点●過剰10%未満＋過少80%未満で2点 ●過剰が全体の10%未満で1点●過剰が全体の10%以上は0点
⑩	介護品質の低下・業務負担の増加を適切に把握できる体制ができている	●未タップ率 ●入院/退去後の修正 ●1援助1記録	●未タップ２%未満：1点 ●入院退去後2週間以内に修正：1点 ●1援助1記録が20%未満：1点 ※この項目は、上記3つの合計3点で判定

・上記10項目で定量評価がなされる際、その合計点が合格ライン（30点満点中20点）をクリアしていれば、「1勝」という判定になります。但し、上記10項目の内１つでも０点があれば不合格となります。
合格ラインは全項目を評価する際に明確化します。
・各ホームの定量評価に加え、本部ごと、事業部ごとにも集計し、一覧化して開示いたします。

利用者 良し ＝ 尊厳のある生活

項目	1.ブランドサービスの価値が提供され、より豊かな生活が送れている	2.状態に応じた適切なサービスを受けることができている	3.ケアプランの内容にご本人の意思や意向が反映され、担当者会議で説明を受けている
確認ポイント	ケアの品質をあげ、より豊かな生活を提供するためのQタイムが十分確保できているか？	状態にあった適切なサービスがプランに位置付けられ、適切にサービスが提供できている状態が保たれているか？	担当者会議の場にご本人が参加し、意思表示ができる環境が整えられているか？
評価指標	**1人あたりのQOL取組み時間/月（Qタイム+個別援助）** ・3点：1人当たり150分以上 ・2点：1人当たり 90分以上 ・1点：1人当たり 30分以上 ・0点：1人当たり 30分未満	**キャンセル率、未実施率** ・3点：5%未満 ・2点：10%未満 ・1点：15%未満 ・0点：15%以上	**本人のサービス担当者会議参加率** ・3点：90%以上 ・2点：80%以上 ・1点：70%以上 ・0点：70%未満
分子詳細	**Qタイム業務＋個別参加援助時間** ※Qタイム業務とはAxistで「Qタイム業務」と位置付けられている13項目（次ページ参照） ※個別参加援助時間とは５項目 ①「趣味・習慣・参加」②「施設アクティビティ付き添い」 ③「買い物同行」④「買い物代行」⑤コミュニケーション	**未実施ケアの総回数** ホーム全体の未実施ケアの総回数（月間合計） ※全てのケア項目 ※利用者と紐づかない施設業務は除外 ※未実施ケアは“その他中止”、“不在中止”、“空振り（拒否）”、“体調不良/中止”含む	**直近2か月間のサービス担当者会議における「本人」が「出席」の数** 分母と同条件の会議の内、アセスｖ４の“出欠”より“本人”が“出席”である会議数（月間合計）
分母詳細	**月末入居者数** ※前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間	**総援助予定回数** ホーム全体の援助予定の総回数（月間合計） ※全てのケア項目 ※利用者と紐づかない施設業務は除外	**直近２か月間での会議数** ①短期目標開始日が毎月1日のみ ②“開催日”が当月及び前月 ③会議種別が“サービス担当者会議” ④会議開催数が複数ある場合は全てカウント ※①～④を全て満たす会議件数（月間合計）
データ参照元	AxistX	介護記録システム	egaku（アセスv4）
対策案	①ご利用者さまのご意見を聴取し、Qタイムに位置付ける個別参加援助やQタイム業務を明確にしましょう。 ※①については、QOLの向上に資する「個別の習慣・参加」「コミュニケーション」などの実施を目的に、ケアプラン（３表）への位置づけを進めることが望ましい。 ②カスタムメイドケアの推進によるケアの見直し、施設業務等の定期的な点検やテクノロジーの導入により、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を見直し、Qタイムの確保に努めましょう。 ③アクティビティ業務の入力ルールについては「Axist入力ルールブックテキスト」を参照ください	①未実施の理由が「自分でできている」「援助を断られる（受けたくない）」「時間や内容が合っていない」のどれに当てはまるのか評価しましょう。 ②「援助中止し自立」「時間・方法見直し」等工夫をして未実施を減らしていきましょう。 ③未実施が多い＝ケアプランに同意が得られていないこととなりますので、ケアプランを軸にご利用者さまと話し合いましょう。 ※新入居、退院直後など手厚めに援助が入っている時期は一時的に多くても問題はない。	①サ担開催日をケアマネジャー中心に更新月にスケジューリングしましょう。 ②①の日程をご利用者さま・ご家族さまへ連絡しましょう。 ③ご利用者さま・ご家族さまとも担当者会議ではご意見を伺い、記録に残すようにしましょう。 ※介護保険サービス事業者として、顧客であるご利用者さま本人には、障がいの程度に関わらず原則参加していただくのは当たり前と認識すること。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞Qライン稼働・Qタイム実施ルールブック ●ファイル管理＞システムマニュアル＞ケアマネジメントシステム＞Axist	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻（下巻）カスタムメイドケア	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻（下巻）カスタムメイドケア

参考）Qライン業務予定項目

「ホーム業務」として追加する
ACP会議・ヒアリング
アクティビティ実施・準備
夢結いのーと作成
利用者持ち物・居室環境整備
ご利用者様の困りごとの情報収集
問題解決型プラン作成・評価
生活リハ付き添い
娯楽外出同行
業務確認・検討
援助同行
手順書作成
情報収集シート作成
担当者会議

“Qタイム” の使い方

手順３＿「何をするか」は、継続を意識して以下の手順を参考に考えてください。

気づきと・よかったことは
その都度共有

人間尊重・自立支援

① 何のためを明確に！	② 何をしたい？（●例えば・・・）	③ Qタイムで何する？ ► 参考例	④ やってよかった効果を共有し、継続させよう
ご利用者さまとスタッフの満足度向上	●ご利用者さまとコミュニケーションを深めたい ●ご利用者さまの今後を一緒に考えたい ●もっと社会参加してもらいたいので自費サービスにつなげるきっかけづくりをしたい	►・夢結いのーとを活用しながら話し合う ・イベントの企画・準備（子ども食堂など） ・お散歩しながらゆっくり話してみる　など ※「ご利用者さまと対話するために○○をする時間」としっかりと決めてください	具体的に決めるとスタッフも他の業務に気を取られずに安心して関わることができます。 Qラインがあって良かったと思える有効活用しましょう ※一部のご利用者さま、スタッフに偏りが出ないようにバランスよく活用するとよいでしょう
ご利用者さまの困りごとの解決	●非定時・NCなどのケアを減らしたい その都度の随時対応から脱却したい ご利用者さまの困りごとが減るとスタッフも安心する ※発生理由を正しく把握し対策につなげたい	► ご利用者さまの困りごとを聞き出す時間として活用 ※時間を有効にするために、事前に困りごとを聞き出すトークスクリプトを作成し活用するとよいでしょう	困りごとがわかったら、解決策をカスタムカンファレンスなどで検討し、取り組みましょう ※非定時・NCが減ったことは実際の数値でも視覚共有するとやってよかったと皆で感じられます
ご利用者さまの能力向上	●できるADL→しているADLにつなげたい 例）援助方法の見直し（おむつ→トイレなど） 機能訓練・アクティビティの充実のための企画・準備、ご利用者さまサポート　など	► ケア手順・介助方法を見直すための検討時間として活用 対象者は全職種で話し合う（CM・ケア・NS） ※できそうな方を優先に選定しましょう	カスタムカンファレンスで結果を共有し、ケアプラン・ケア手順書の改訂へつなげる ※見直しした介助方法は通常のケア時に定着させましょう
スタッフのケア技術の向上・標準化	●ケア手順・援助方法のばらつきをなくしたい ●難しい高度なケアへの対応を共有したい ケア手順書の作成、見直し・同行指導などでスタッフの不安ごとを減らしたい	► ・対象のケア時間に合わせて同行する ・双方のスタッフ同時設定し学びの時間として活用 ※スタッフ間で手順を一緒に学ぶ時間として通常ケアとは別にすることも可能	スタッフ間での時間はネガティブではなくスキルアップの楽しい時間であることを皆で意識することが大切です ※不安が減った、他のスタッフの技術を見て参考になったなどを積極的に伝えあいましょう

スタッフ良し＝働きがい・働きやすい職場の実現

項目	4.無理なく業務遂行できる 業務スケジュールが組まれている	5.適切な提供時間、タイミングでサービス提供となるスケジュールが組まれている
確認 ポイント	ラインが詰まりすぎており、職員に余裕のない 業務状況になっていないか？	提供が困難、ないしはリスクが生じると思われるような業務スケジュールの組み方、援助の所要時間になっていないか？
評価指標	**直接介護ライン（夜勤を除く）の業務ゆとり時間（＝空き時間）割合** ・3点：平均が 20%以上 ・2点：平均が 15%以上 20%未満 ・1点：平均が　5%以上 15%未満 ・0点：平均が　5%未満 ※上限は不問	**援助別ミニマム時間の割合** （オムツ交換・トイレ介助・着脱介助・口腔ケア介助 ・食事介助・入浴介助の6項目） ・2点：60%以上 ・1点：20%以上60%未満 ・0点：20%以下
分子詳細	**直接介護ライン（夜勤を除く）の空き時間数** ※「ライン区分」で「介護」と位置付けられ、かつ、夜勤以外のラインの空き時間数 （AxistX＞マスタ管理＞マスタ保守（業務管理表）＞ラインマスタ保守にて入力）	**ミニマム時間以上に設定された援助予定回数** 対象となるケア項目において、それぞれ右表に定める ミニマム時間以上の時間で設定されている1ヶ月の回数
分母詳細	**直接介護ライン（夜勤を除く）の総勤務時間数**	**ミニマム時間を定義したケアの総予定回数** “オムツ交換”、“トイレ介助”、”着脱介助”、“口腔ケア介助”、 “食事介助”、“入浴介助”の1ヶ月の全援助予定回数
データ参照元	AxistX	AxistX
対策案	①Axistの各ラインの業務飽和度を確認し、ラインによる偏りがないかを確認しましょう。（マルチタスクがある場合は要注意） ②未実施やキャンセル率の高い援助がないか確認し、ケアの見直しを検討しましょう。 ③介護度の基準援助時間との差異がある方を確認し、過剰援助がないか確認しましょう。	①tableau「カスタムメイドケア実践を図る10の評価項目」の「ミニマム時間明細」にてどのご利用者さまが設定値が低いのかを確認しましょう。 ②「着脱介助1分」「トイレ介助2分」など明らかに適切ではない可能性の高いものは、時間の修正を行ってください。 ※全ての時間帯で、全てのご利用者さまに、この時間を確保しなければならないものではありません。 しかし、Axistはケアプランの反映＋業務管理ソフトです 援助を詰め込まず、説明や記録に時間をあててもらい、ケアスタッフに無理をさせないことは、接遇やホスピタリティの視点からも大切です。
動画 マニュアル案	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻（上巻）未来の介護 ●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞カスタムメイドケア・egaku関連＞egaku活用・分析ルールブック	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻（下巻）カスタムメイドケア

参照：　ミニマム時間とは

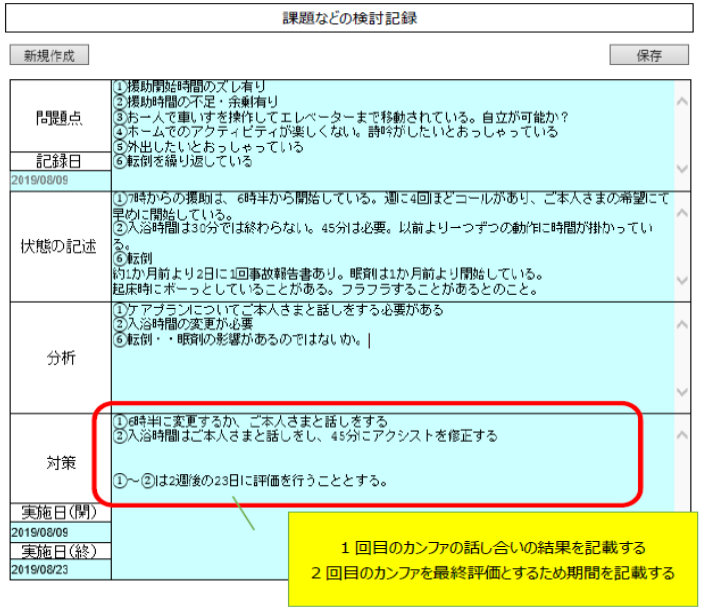
品質保持を目的として最低限確保したい各ケア項目ごとの援助時間をミニマム時間と定義し、以下に定めるものとする

※数値根拠は実証事業12ホームの取組後の平均分数に2分プラスしています。「人間尊重」の考え方から、この6つの援助については能力向上、コミュニケーション、記録のためゆとりのある援助時間を推奨します。

オムツ交換	６分
トイレ介助	６分
着脱介助	５分
口腔ケア介助	５分
食事介助	１８分
入浴介助	３０分

スタッフ良し＝働きがい・働きやすい職場の実現

項目	6.ご利用者さまのQOL維持向上のために多職種で暮らしを支えられている
確認ポイント	カスタムカンファが適切に実施され、多職種の意見によりケアが適宜見直されているか？
評価指標	**カスタムカンファ議事録作成状況** ・3点：80%以上 ・2点：70%以上 ・1点：60%以上 ・0点：60%未満
分子詳細	**「課題などの検討記録」の数** カスタムカンファの「記録日」と「評価日」が更新日より遡って90日以内に作成されている利用者数
分母詳細	**更新者数** 短期目標開始日が当月1日かつ ケアプラン１表の区分が“継続”の利用者数 ※4月分の場合は4月1日開始プランが対象
データ参照元	egaku（アセスv4）
対策案	①カスタムカンファ対象者が適切に選択されているか確認しましょう。 ②問題解決型プランで議事録作成している場合はカウントされません。 ③カンファを円滑に進めるための、事前議事録、カンファ中の作成を推奨します。 ④ケアプランにつなげるために、また各職種で内容共有できるように議事録は重要です。 ⑤エクセルやワード等紙ではなくデータとして保管できるシステム管理へ移行しましょう。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞カスタムメイドケアegaku関連＞【未来の介護】カスタムメイドケアカンファレンスとegaku



事業者 良し ＝未来の介護モデルの創造

項目	7. QOL取組みの実施に向け、直接介護のケアライン数が既定本数に準じて運営できている	8.将来、介護ができる人材が減ったとしても高齢者の生活を支え続けられる体制ができている	9.過剰・過少援助とならぬよう、ご本人の状態にあったサービスが提供できている
確認ポイント	変動要素に左右されすぎることなく、継続可能な体制を維持するための基準を意識できているか？	万が一、介護人材が不足した際に、Qラインをアクティブシニアや外部委託することができる状態が想定できているか？	介護保険報酬に見合ったサービスが提供がされ、利用者ごとの不公平が生じていないか？
評価指標	**直接介護実施の業務ライン数** ・3点：直接援助のケアライン数の基準内 ・2点：直接援助のケアライン数より多いが1本未満 ・1点：直接援助のケアライン数より1本多い ・0点：上記以外	**Qラインに直接介護が入っていない** ・3点：直接介護 0% ・2点：直接介護 5%未満 ・1点：直接介護10%未満 ・0点：直接介護10%以上 ※QラインはAxist上「動かさない」を基本ルールとする。 Qラインが存在しない場合は3点とする	**援助量と介護度の一致** ・3点：過剰10%未満＋過少60%未満 ・2点：過剰10%未満＋過少80%未満 ・1点：過剰10%未満 ・0点：過剰10%以上
分子詳細	**定員数によるモデル基準ラインとの差異** 各ホームで定めた「基準ライン本数」に準ずる「直接介護」（ライン区分「介護」）ラインの1ヶ月のライン総本数/1ヶ月の日数（30日又は31日、2月のみ28日）	**Qラインの直接介護時間** 1ヶ月のうちQライン上に配置されている直接介護時間数	**「援助過剰」対象者** 援助予定時間が一つ上の介護度の基準時間を超過している利用者数 ※境界値を含まない **「援助過少」対象者** 援助予定時間が一つ下の介護度の基準時間を下回る利用者数 ※境界値を含まない
分母詳細	夜勤は入り、明けは別々のライン。 深夜勤の場合は「入り」「明け」を1本のラインで表記してください。	**Qラインの総援助時間** 「ライン区分」として1ヶ月に設定されているQラインの時間数	**月末利用者数** 前月末日の利用者数
データ参照元	AxistX	AxistX	AxistX
対策案	①援助過剰の場合は「区分変更」か「援助内容・回数・方法の見直し」を実施しましょう。 ②介護保険収入に対する労務費率を確認し、妥当な場合は、ピークタイムの業務の組み換えの検討をしましょう。 ③労務費率が著しく低い場合は、必要なライン本数について、検討が必要です。	①Qラインに調節介護が入っている場合は直接介護ラインの見直しを行い、移行させましょう。 ②新入居や退院直後など、やむを得ず一時的に発生したQライン上の直接介護については、期限を決めて状態の確認や必要援助の見極めを行い、プランの見直しを進めましょう ③「直接介護」に分類されている援助については、「Qライン稼働・Qタイム実施ルールブック」を参考にしてください。	①援助過剰の場合は「区分変更」か「援助内容・回数・方法の見直し」を実施しましょう。 ②援助過少の場合は「非定時ケア」「回数・時間の不足」「自立支援の為の時間確保」を評価しましょう。 ③Axist入力方法の問題がないか（個別援助をホーム業務にしている、又はその逆）見直しましょう。 ※1割・6割等の指標はアラートであり、個別の対応が必要。上記の①②③が実施できていればよい。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞カスタムメイドケア・egaku関連＞egaku活用・分析ルールブッ	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞Qライン稼働・Qタイム実施ルールブック ●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞カスタムメイドケア・egaku関連＞egaku活用・分析ルールブック	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻（下巻）カスタムメイドケア

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
家・L共通	105	133	203	413	553	756	1113

未来社会 良し ＝未来の介護モデルの創造

項目	10.介護品質の低下・業務負担の増加を適切に把握できる体制ができている		
確認ポイント	実施したサービスを、 証跡として正しく記録できているか？	現在の業務量を正確に業務予定として把握し、 業務管理表に反映しているか？	正確な業務実態や精度の高い情報を把握するため、 リアルタイムで記録できているか？
評価指標	**未タップ率** ・1点：2%未満 ・0点：それ以外	**入院/退去後の修正状況** ・1点：1ヶ月で２名以下 ・0点：それ以外	**排泄援助のズレ率** ・1点：20%未満 ・0点：それ以外
分子詳細	**記録がされなかったケア（未タップ）件数** ※予定されている日付の23:59までに記録されなかったケアの件数 ※毎週月～日曜で各週ごとに集計	**入院・退去の登録がされた日を起点に14日以上先にケア予定が入っている利用者数**	**排泄予定から30 分以上ずれた総援助回数** ケア項目“排泄”の援助予定の内、予定時刻から 30 分以上のズレが発生した回数（月間合計）
分母詳細	**全ての援助予定件数** ※AxistXでスケジュール設定し介護記録システムに連携された件数 ⇒1週間ごとの集計結果を4週分合算し月平均算出	分子による単純表記（分母なし）	**排泄ケアを含む総予定件数** ケア項目“排泄”の総援助予定回数（月間合計）
データ参照元	介護記録システム	AxistX ほのぼのより「入院」実績と「退去」情報	介護記録システム
対策案	①勤務終わりに、当日のスケジュールを確認し、未タップがないかどうか確認する時間を設けましょう。 ②egakuにて、未タップが多いラインを確認し、原因を精査しましょう。	①週に1回はAxistを修正し、修正時はまず入院や退去等の発生を確認するようにしましょう。 ※Axistは業務予定の管理表ですので、予定にないケアは修正してください。また、退院時に退院前のスケジュールのままでケア提供を行う前提ではなく、状態に合わせたケアの見直しを行いましょう。 ※急な変更（退院予定が延期になった等）は退院予定日の前日20時までの修正（削除）を行うことでegakuへの取り込みを中止できます。	①tableau「カスタムメイドケア実践を図る10 の評価項目」の「排泄ケア明細」にてどのご利用者さまが多いのかを確認しましょう。 ②「タップ遅れ」が理由の場合、速やかな記録の重要性を周知しましょう。 ③Axistと現場の乖離があれば、Axistを速やかに変更しましょう。 ④援助のお断りなどある場合は、ご利用者さま・ご家族さまとケアプランを中心に話し合ってください。 ※多少の援助のズレはやむを得ませんが、サービス事業者として、時間はケアプランでご利用者さまと約束したものであることを認識しておきましょう。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞カスタムメイドケア・egaku関連＞egaku活用・分析ルールブック	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻（下巻）カスタムメイドケア	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻（下巻）カスタムメイドケア

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
家・L共通	105	133	203	413	553	756	1113